

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	顱內壓升高 Increased Intracranial Pressure; IICP				
編號	A31000-Q03-W-A03	制定者	SI 朱卉愉	公布日期	98 年 05 月 31 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 3.6 版/8 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解顱內壓升高的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

腦組織、腦脊髓液和血液形成腦部顱內壓的一個穩定的循環，但是當其中的一項無法正常的維持身體的循環時，常會造成顱內壓升高的情形。

（二）症狀

1. 意識程度改變：起因於腦部血流供應不足，因而影響大腦皮質與網狀致活系統中之神經細胞功能。對於病人神經功能狀況之評估，意識程度改變是一重要且敏感的指標。
2. 生命徵象改變：隨著顱內壓力的逐漸增加，血壓、脈搏、呼吸、體溫方面會隨之改變。
3. 眼睛徵象：瞳孔放大、視力模糊、複視、視乳突水腫。
4. 運動功能減弱：臨床可見對側的半身麻痺或半身輕癱。
5. 頭痛：通常由顱內壓上升造成之頭痛是持續性的，而且在清晨時最為嚴重。
6. 嘔吐。

主題名稱	顱內壓升高	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A03	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	2/8

7. 腦幹反射消失：洋娃娃眼陰性反應表示中腦受傷；角膜反射消失表示橋腦有問題；吞嚥、作嘔反射消失表示延腦有問題。

（三）常見檢查

1. 電腦斷層。
2. 核磁共振。
3. 顱內壓監測法。

（四）常見治療

1. 外科手術治療：使用外科手術治療，主要是希望能將病因切除，此外尚可藉由裝置分流管或減壓手術，使得顱內高壓獲得暫時性緩解。

2. 非外科手術治療：

(1) 藥物治療：

A. 利尿劑：主要是將滲透性利尿劑注入血管內，利用滲透壓之差距使腦組織水份自組織中流入血管內，藉以改善腦水腫的現象。

B. 類固醇：類固醇之治療機轉目前尚未完全了解，因此是否使用類固醇來降低顱內壓，目前仍然在爭議之中。

C. 巴比妥酸鹽：可以降低腦組織的新陳代謝率，使得血流可以均勻的供應腦部需要，因而減低腦血腫，有效降低顱內壓。

(2) 限制水分：因中度脫水可以維持血液之滲透壓，並有助於降低腦部水腫。

(3) 營養供應：由於營養不良會促使腦組織呈現持續性之水腫，因此維持病人適

當、充分之營養攝入是非常重要的。

（五）護理問題

1. 顱內壓力調適困難／與顱內壓升高有關。
2. 無法有效呼吸／與神經功能失調（腦幹受壓、腦組織移位）有關。
3. 易體液容積不足／與治療導致脫水有關。

主題名稱	顱內壓升高	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A03	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	3/8

4. 排便異常：便秘／與藥物影響、神經功能失調、使用導尿管、減少水分與食物之攝入量、活動改變有關。

5. 易感染／與顱內壓監測器有關。

(六) 護理措施

1. 顱內壓力調適困難／與顱內壓升高有關：

(1) 監測記錄生命徵象。

(2) 急性期每 1-2 小時監測尿量及比重並記錄。

(3) 監測每天的輸出入量並記錄。

(4) 注意能活動病人的安全，防意外發生，如：姿勢性低血壓引起昏眩而跌倒。

(5) 隨時注意因血清電解質不平衡引起的症狀及徵象，EX：意識改變、心電圖變化。

2. 無法有效呼吸／與神經功能失調（腦幹受壓、腦組織移位）有關：

(1) 評估和記錄呼吸型態。

(2) 監測血氧濃度、生命徵象、動脈血液氣體分析值並報告異常值。

(3) 維持足夠營養攝取量以供呼吸肌和呼吸所需的熱量。

(4) 依醫囑給予持續性靜脈注射支氣管擴張劑。

(5) 依醫囑給予藥物和評估效果（例如：支氣管擴張劑、抗發炎藥物等）。

(6) 依醫囑維持靜脈輸液狀況。

(7) 依醫囑給予氧氣治療，並評估治療效果。

(8) 持續性評估和記錄護理措施的效果。

3. 易體液容積不足/治療導致脫水有關：

(1) 評估皮膚飽滿度。

(2) 觀察是否有脫水的現象（唇裂、口腔黏膜乾燥）。

(3) 監測生命徵象。

主題名稱	顱內壓升高	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A03	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	4/8

(4)監測輸入量及排出量及尿比重。

(5)維持靜脈輸入治療管路通暢，必要時隨時補充液體。

(6)監測與體液容積缺失有關的各項檢驗結果。

(7)補充足夠的水份及維生素，預防脫水。

(8)避免皮膚暴露在乾燥環境。

(9)告知病人關於體液容積喪失的知識。

4. 排便異常：便秘與藥物影響、神經功能失調、使用導尿管、減少水分與食物之攝入量、活動改變有關：

(1)超過 3 天未排便或有不舒服之主訴時，可依醫囑給藥或灌腸以協助解便。

(2)教導病人記錄 48 小時的所有攝取食物。

(3)與病人討論進食型態。

(4)教導並鼓勵病人減少油炸及刺激性食物之攝取，增加高纖維素食物，如：
穀類食品。

(5)麵包、水果、蔬菜、果仁和種子等的攝取。

(6)注意當在增加食用高纖維食物的同時，也須增加水份或流質的攝取量，建議每天喝 2000-2500c.c 水以利軟化糞便，以免便秘加劇。

(7)養成良好之排便習慣，如：習慣餐後上廁所、每天定時上廁所（例如在早上）。

5. 易感染／與顱內壓監測器有關：

(1) 監測生命徵象。

(2) 監測全血球計數(CBC)並報告 WBC 異常現象。

(3) 記錄及檢查傷口滲出液顏色、氣味、濃稠度、癒合情況。

(4) 觀察傷口敷料外觀。

(5) 治療前後洗手。

(6) 無菌技術收集標本培養以監測感染存在。

主題名稱	顱內壓升高	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A03	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	5/8

- (7) 依醫囑正確使用冰或熱敷。
- (8) 依醫囑按時給予抗生素。
- (9) 依醫囑以無菌技術換藥。
- (10) 教導保持傷口乾燥及清潔且避免壓迫傷口並協助、教導翻身方式。
- (11) 教導感染的危險因子及預防感染的重要性方法。
- (12) 指導炎症症狀及徵象。

(七) 衛教指導

1. 教導病人於床上移位、排便時避免採用 Valsalva's 動作，即閉氣用力運動在床上翻身。
2. 移位時，最好於吐氣時開始動作。
3. 鼓勵攝取高纖維飲食，避免便秘情形。
4. 告知家屬及病人顱內壓升高之症狀：躁動不安、頭痛、呼吸費力、無目的的活動、意識模糊、頭痛、嘔吐。
5. 教導抬高床頭 30 度，避免採取頭低腳高及俯臥的姿勢，造成顱內壓升高。
6. 翻身時使用固定枕固定於頭部，維持頭部與身體一直線，以避免減少顱內靜脈回流及減少腦脊髓液引流而導致顱內壓升高。
7. 注意床欄使用，預防跌倒的發生。
8. 若病人發燒，教導正確冰枕使用方式，頭部有傷口者以腋下夾冰方式使用。
9. 避免噪音吵雜，維持病人單位的安靜，以提供患者充分的休息。
10. 病人若使用導尿管，教導注意會陰部清潔及導尿管護理（可用肥皂水清洗會陰處與導尿管插入處）。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

主題名稱	顱內壓升高	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A03	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	6/8

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 唐景俠、黃秀雲、吳孟凌、宋寧娟、盤松青、李德芬、宋琇鈺、蔡玉梅、張淑娟、翁黃玲、胡名宏、張惠甄、盧星華、周心如、林琪馨、白玉珠、李芸玫、周學智、....、蘇淑芬(2021)·急重症護理學·台北市：華杏。
- (二) 張美玉、劉慧玲(2020)·實用重症護理學·台中：五南。
- (三) Saria, M. G., & Kesari, S. (2021, April). Increased Intracranial Pressure: The Use of an Individualized Ladder Approach. In Seminars in oncology nursing(Vol. 37, No. 2, p. 151133). WB Saunders.
- (四) Schizodimos, T., Soulountsi, V., Iasonidou, C., & Kapravelos, N. (2020). An overview of management of intracranial hypertension in the intensive care unit. Journal of anesthesia,34(5), 741-757.

七、附件

(略)

主題名稱	顧內壓昇高	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A03	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
98.05.31	1.0	新制定	98 年 05 月 31 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	修改說明內容與錯別字	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	1.醫護部改護理部 2.刪除：第六項(1995)參考資料	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.02.03	3.1	1.新增第三項第(七)目之 6 2.更新第六項參考資料部份內容	104 年 02 月 03 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.2	1.更新第六項參考資料部份內容 2.新增參考文獻出處於內文中	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.02.12	3.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.3	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	3.4	第三項第八目本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過;108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.06	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	顱內壓昇高	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-A03	版本	第 3.6 版	頁碼/總頁數	8/8

修正日期	版本	修正說明	備註
110.08.05	3.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	3.5	1. 更新第三項第五、六目護理問題。 2. 第六項參考資料。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.08.08	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
114.10.08	3.6	第六項第五目參考資料刪除。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。